

7 嚙声（音声障害） hoarseness (dysphonia)

到達目標

- 嚙声の原因疾患，特に全身疾患による原因疾患を列挙できる
- 嚙声の原因を鑑別するための問診，身体所見，検査を遂行できる
- 嚙声患者の治療および処置について概説できる
- 耳鼻咽喉科専門医へ紹介する適切なタイミングを判断できる

嚙声（音声障害）とは、「音質，声の高さ，声の大きさ，発声努力などの変化により，コミュニケーションを損なう，あるいは声のQOLが低下すること」と定義されている¹⁻³⁾。

嚙声（音声障害）の診療においては，呼吸器専門医は耳鼻咽喉科，脳神経内科，精神神経科など他科と協同して診療を行うことが多い。致死的な疾患が基礎にあることもまれではなく，適切な判断と他科との連携が求められる。

病態・原因疾患

a 病 態

発声は左右の声帯と後輪状披裂筋で構成される声門を呼気が流れることで成立し，口腔および鼻腔が音響効果を担う。そのため嚙声は，①声帯自体の異常，②声帯に異常を及ぼす神経筋群の異常，③呼気の異常，④口腔や鼻腔のどこかの異常により起こる。すなわち，声門局所だけでなく呼吸器を含む全身の疾患が嚙声の原因となる。

b 疫 学

嚙声の頻度について国内でのまとまった報告はないが，米国では人口の1/3が過去に音声障害を経験したことがあり，約7%が音声障害のために過去1年以内に休職経験を持つ^{1, 2)}。本邦の疫学研究では，教師における音声障害の自覚頻度は8.5～54%と報告されており，特に週間担当授業数の多い場合や，低学年の担当者，国語・音楽担当者で頻度が高い³⁾。

c 原 因

音声障害の原因は多岐にわたる。罹患期間が2週間以内を急性，それ以上を慢性とするが，急性嚙声の原因は良性疾患がほとんどである（表1）⁴⁾。

この中で呼吸器専門医が多く経験する可能性が高いものは，声帯麻痺と薬剤による嚙声であり，そのメカニズムを理解しておく必要がある。

i) 迷走神経障害，反回神経障害

声帯を動かす5つの内喉頭筋群の神経支配は上喉頭神経と反回神経であり，いずれも迷走神経から発する（図1）⁵⁾。迷走神経は頸静脈孔より頭蓋外に出て，頸

表1 よくみられる，あるいは重要な嚙声の原因

1. 炎症あるいは刺激物
アレルギーと刺激物（アルコール，タバコなど）
直接外傷（挿管）
環境刺激物
感染症（上気道感染症，真菌性喉頭炎）
咽喉頭または胃食道逆流
薬剤
音声酷使
2. 腫瘍または物理的病変
良性の声帯病変
異形成
喉頭乳頭腫症
悪性腫瘍（喉頭癌，肺癌など）
3. 神経筋および精神疾患
加齢に伴う声帯萎縮
多発性硬化症
筋緊張性発声障害
重症筋無力症
神経損傷（迷走神経，反回神経）
パーキンソン病
心因性（転換失声含む）
痙攣性発声障害（喉頭ジストニア）
脳卒中
4. 全身疾患
末端肥大症
アミロイドーシス
甲状腺機能低下症
炎症性関節炎（輪状披裂関節障害）
膠原病（全身性エリテマトーデス）
サルコイドーシス

[House SA, et al : Am Fam Physician 96 : 720, 2017 より引用]

動脈鞘内を，頸動脈・静脈の間に沿って下行する。右反回神経は右鎖骨下動脈下面，左反回神経は大動脈弓下面から大動脈肺動脈窓（AP window）を反回し，気管食道溝を上行し，輪状甲状関節近傍を通過して，喉頭内に進入する。この経路のいずれかで障害が起こると声帯麻痺が発症する。迷走・反回神経障害による片側声帯麻痺は，頭頸部手術による損傷および挿管時損傷によるものが多い。非手術的原因では頭頸胸部の悪性腫瘍の浸潤（甲状腺癌26%，肺癌11%，食道癌7%，縦隔腫瘍4%，頸部転移癌2%，脳腫瘍2%）や大動脈瘤（6%），脳血管障害（5%），多発性神経炎（3%），特発性（27%）などがある。

ii) 薬剤による嚙声

薬剤による嚙声として吸入ステロイド薬（ICS）によるものがよく知られている。その原因はステロイドの沈着あるいは真菌性喉頭炎である。それ以外の薬剤